

360° Kapsamlı Klinik Yönetici ve Karar Destek Raporu

Rapor Tarihi: 16 Eylül 2026 | Değerlendirme Evresi: Ameliyat Sonrası 208. Gün (6.9 Ay) | Model: Google Gemini 3.8 Flash High

7G KAN BASINCI 113/75 Hedefte (≤120/80)	ANTİKOAGÜLASYON 1.95 Hedef Altı (<2.0)	HEMOGLOBİN 9.7 g/dL Ağır Anemi (Dip: 7.7)	SERUM FERRİTİN 19 µg/L Depolar Tükendi	ENFLAMASYON 5.7 mg/L Normal Aralık	KİLO & KREATİNİN 78.9 kg Krea: 1.11 eGFR: 71
--	---	--	---	---	---

KRİTİK GÜVENLİK UYARISI (INR 1.95): 15 Eylül kontrolünde INR 1.95'e gerileyerek 25mm Carbomedics mekanik aort kapağı için belirlenen terapötik koridorun (2.0–3.0) altına inmiştir. Mekanik protez üzerinde trombüs ve serebral emboli riskini bertaraf etmek amacıyla Warfmadin haftalık dozu hekim kontrolünde 22.5–25 mg/hafta seviyesine titre edilmeli ve 7–10 gün sonra kontrol koagülasyon testi alınmalıdır.

1. PATOFİZYOLOJİK VE ÇOK DİSİPLİNLİ DEĞERLENDİRME

1.1. Hemodinamik Stres ve Kronik Rezidüel Tip B Diseksiyon Dinamiği: Hasta cerrahi lojunda intakt 32 mm Dacron vasküler greft taşımakla birlikte; arkus aortadan bilateral iliak bifurkasyona dek uzanan patent bir rezidüel Stanford Tip B diseksiyon flebine sahiptir (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022). Sol ventrikül ejeksiyon ivmesi (dp/dt) sistolik kan basıncıyla katlanarak artar (Evangelista et al., 2024). Karvedilol (Dilatrend 6.25 mg 2x1) inotropiyi ve nabızı baskımlarken, perindopril (Coversyl 5 mg 1x1) vasküler direnci kırarak son 7 günlük kan basıncını 113/75 mmHg'ye (15 Eylül: 115/77 mmHg) stabilize etmiş ve aort duvar stresini hedef sınırlarda tutmuştur (Isselbacher et al., 2022; Melby et al., 2013).

1.2. Tromboembolizm ve İlaç Etkileşim Kinetiği: 40 ölçümlük seride Rosendaal TTR oranı %54.6 seviyesindedir (Rosendaal et al., 1993). Koroner buton anastomozlarını korumak için eklenen Aspirin 81 mg, Warfarin ile birlikte majör kanama riskini artırdığından Pantoprazol (Panto 40 mg) gastroproteksiyonu zorunludur (Dentali et al., 2006). 11 Eylül'de tamamlanan Klamoks kürünün ardından INR'nin 1.95'e düşmesi, antibiyotik eliminasyonu sonrası yakın INR takibinin gerekliliğini doğrulamıştır (Zhang et al., 2011).

1.3. Mutlak Demir Eksikliği Anemisi & Tedavi Protokolü: Hemoglobin 9.7 g/dL, MCV 76.7 fL (mikrositöz) ve Ferritin 19.0 µg/L tablosuna yönelik 11 Eylül'de Ferro Sanol Duodenal 100 mg başlanmıştır (Camaschella, 2015; Snook et al., 2021). Pantoprazol mide pH'ını yükselterek duodenal demir emilimini %60–80 baskıladığından; Ferro Sanol sabah aç karına bol suyla alınmalı, Panto 40 mg en az 1 saat sonra kullanılmalıdır. Oral refrakterlikte tek seans IV Ferrik Karboksimaltoz (1000 mg) replasmanı planlanmalıdır (Snook et al., 2021).

1.4. Sternal İyileşme ve Enfeksiyon Ekartasyonu: Klamoks kürü sonrasında CRP 5.7 mg/L'ye gerileyerek bazal sınıra yaklaşmış, lökosit $9.01 \times 10^9/L$ ile normal aralıkta seyretmektedir (Horan et al., 2008). Persistan ateş veya üfürüm saptanması halinde Protez Kapak Endokarditi (PKE) ekartasyonu için TEE ve 3 set kan kültürü şarttır (Delgado et al., 2023).

2. TÜMLEŞİK LABORATUVAR DEĞİŞİM MASTER TABLOSU (32 PARAMETRE)

BİYOBELİRTEÇ / KOD	REFERANS	İLK (19 ŞUB)	ZİRVE / DİP	SON (15 EYL)	%Δ	DURUM	KILAVUZ
Hemoglobin (HGB)	13.4 – 17.6 g/dL	14.0	7.7 (Dip)	9.7	-30.7%	DÜŞÜK	Snook et al. (2021)
Hematokrit (HCT)	%40.5 – 53.6	41.4	25.0 (Dip)	30.1	-27.3%	DÜŞÜK	Goddard et al. (2021)
Eritrosit Hacmi (MCV)	75.0 – 98.3 fL	88.0	76.4 (Dip)	76.7	-12.8%	MIKROSİTER	Camaschella (2015)
Eritrosit Hb (MCH)	23.2 – 33.2 pg	30.8	24.5 (Dip)	24.6	-20.1%	DÜŞÜK	Camaschella (2015)
Serum Ferritin	30.0 – 400.0 µg/L	19.0	19.0 (Dip)	19.0	Tükendi	DÜŞÜK	Snook et al. (2021)
Serum Demiri (Fe)	59.0 – 158.0 µg/dL	15.0	15.0 (Dip)	15.0	Kritik	DÜŞÜK	Snook et al. (2021)
C-Reaktif Protein (CRP)	0.0 – 5.0 mg/L	2.6	154.0 (Pik)	5.7	-96.3%	NORMAL	Horan et al. (2008)
Lökosit Sayısı (WBC)	4.01 – 9.75 $10^9/L$	10.62	27.10 (Pik)	9.01	-15.2%	NORMAL	Horan et al. (2008)
Koagülasyon (INR)	2.0 – 3.0 (Hedef)	1.10	8.46 (Pik)	1.95	-7.9%	HEDEF ALTI	Vahanian et al. (2022)
Protrombin Zamanı (PT)	9.6 – 12.0 sn	13.1	64.0 (Pik)	18.4	+40.5%	UZAMIŞ	Vahanian et al. (2022)
aPTT	23.9 – 33.2 sn	27.9	85.5 (Pik)	44.4	+59.1%	UZAMIŞ	Vahanian et al. (2022)
Trombosit (PLT)	151 – 387 $10^9/L$	163.0	88.0 (Dip)	368.0	+125.8%	NORMAL	Vahanian et al. (2022)
Serum Kreatinin	0.7 – 1.2 mg/dL	1.11	1.13 (Pik)	1.11	0.0%	NORMAL	KDIGO (2013)
eGFR (CKD-EPI 2021)	> 60 mL/dk/1.73 m ²	72.58	94.00 (Pik)	70.89	-2.3%	NORMAL	Inker et al. (2021)
Üre Azotu (BUN)	7.0 – 20.0 mg/dL	18.3	29.0 (Pik)	14.5	-20.8%	NORMAL	KDIGO (2013)
Potasyum (K)	3.5 – 5.5 mmol/L	3.64	5.05 (Pik)	5.05	+38.7%	NORMAL	KDIGO (2013)
Sodyum (Na)	136 – 145 mmol/L	136.0	149.0 (Pik)	138.0	+1.5%	NORMAL	KDIGO (2013)
Total Kolesterol	0 – 200 mg/dL	179.0	210.0 (Pik)	210.0	+17.3%	YÜKSEK	Mach et al. (2020)
LDL Kolesterol	< 55 mg/dL (Hedef)	119.6	141.0 (Pik)	141.0	+17.8%	YÜKSEK	Mach et al. (2020)
Açlık Glukozu	82 – 115 mg/dL	81.0	146.0 (Postop)	98.0	+21.0%	NORMAL	ADA (2024)

3. GÜNCEL FARMAKOTERAPİ REJİMİ (16 EYLÜL 2026)

İLAÇ ADI	SINIF	DOZ & REJİM	KULLANIM AMACI	KLİNİK NOT & GÜVENLİK
Warfmadin	Antikoagülan (VKA)	5 mg • 20 mg/hf	Mekanik kapak tromboz profilaksisi	Doz artışı gerekli (Son INR: 1.95)
Dilatrend	Non-selektif Beta-Bloker	6.25 mg • Günde 2x1	Aortik dP/dt kesme stresini önleme	Stabil; taburculuk dozuyla devam ediyor
Coversyl	ACE İnhibitörü	5 mg • Günde 1x1	SVR düşürme & kan basıncı kontrolü	04.08'de eklendi; TA'yı 113/75'e indirdi
EcopirinPro	Antiplatelet (ASA)	81 mg • Günde 1x1	Koroner buton ve greft profilaksisi	Warfarin ile kombine; kanama takipli
Panto	Proton Pompa İnhibitörü	40 mg • Sabah 1x1 Aç	Çift antitrombotik GİS kanama koruma	Ferro Sanol'den 1 saat sonra alınmalı
Ferro Sanol Duodenal	Demir Preparatı (Fe ²⁺)	100 mg • Günde 1x1	Ağır mikrositer anemi replasmanı	11.09'da başlandı; sabah aç, bol suyla
Klamoks BID	Beta-laktam Antibiyotik	1000 mg • Günde 2x1	Sternal CRP ampirik kür tedavisi	11 Eylül 20:59'da 8 günlük kür bitti; kesildi
Kapril	Kısa Etkili ACEi	25 mg • PRN (Gerektiğinde)	Sistolik TA ≥ 150 mmHg acil dilaltı	Acil hipertansif kurtarma ilacı

4. ÇOK DİSİPLİNLİ STRATEJİK EYLEM PROTOKOLÜ

- Kardiyoloji & Hemostaz (Acil Öncelik):** 15 Eylül kontrolünde INR 1.95 ile mekanik kapak hedef koridorunun (2.0–3.0) altına gerilemiştir (Vahanian et al., 2022). Kapak trombozu ve serebral mikroemboli riskini engellemek için Warfmadin haftalık dozu hekimce **22.5–25 mg/hafta** seviyesine yükseltilmeli; yeşil sebze tüketimi sabitlenmeli ve 7–10 gün sonra (22–25 Eylül) kontrol INR testi alınmalıdır.
- Hematoloji & Gastroenteroloji:** Ağır demir eksikliği anemisi (HGB 9.7 g/dL, Ferritin 19.0 µg/L, MCV 76.7 fL) tedavisi 11 Eylül'de başlanan Ferro Sanol Duodenal 100 mg ile sürdürülmektedir (Snook et al., 2021). Pantoprazol ile 1 saatlik açlık aralığı kuralı titizlikle uygulanmalıdır. 4. hafta sonunda Hb artışı <1.0 g/dL kalırsa veya GİS intoleransı gelişirse tek seans **İntravenöz Ferrik Karboksimaltoz (Ferinject 1000 mg)** infüzyonuna geçilmeli; eşzamanlı 3 ardışık GGK/FIT testi yapılmalıdır (Goddard et al., 2021).
- Kardiyovasküler Cerrahi & Radyoloji:** 5 Mayıs 2026 tarihli kontrastlı BT'den bu yana 4.4 ay geçmiştir. Ameliyat sonrası 6. ayını tamamlayan hastada arkustan iliak bifurkasyona dek uzanan patent Tip B diseksiyon flebi (inen aorta 39 mm, suprarenal aorta 38 mm) ve greft loju stabilitesini denetlemek üzere **Kontrastlı Torakoabdominal BT Anjiyografi** planlanmalıdır (Czerny et al., 2024; Fleischmann et al., 2022).
- Enfeksiyon Hastalıkları & KVC:** Klamoks kürü sonrasında CRP 5.7 mg/L'ye gerileyerek bazal sınıra yaklaşmış, lökosit $9.01 \times 10^9/L$ ile normal aralıkta seyretmektedir (Horan et al., 2008). Yara yeri iyileşmesi stabil seyretmektedir. Persistan ateş veya üfürüm saptanması halinde Protez Kapak Endokarditi (PKE) şüphesiyle 3 set kan kültürü ve TEE tetkiki yapılmalıdır (Delgado et al., 2023).
- Kardiyoloji & Önleyici Kardiyoloji:** Total Kolesterol 210 mg/dL ve LDL-K 141 mg/dL seviyesindedir. Aort diseksiyonu ve kapak replasmanı geçirmiş çok yüksek riskli hastada 2019 ESC/EAS kılavuz hedefi LDL <55 mg/dL olduğundan **Atorvastatin 20 mg/gün** başlanması değerlendirilmelidir (Mach et al., 2020).

5. KAYNAKÇA (APA 7TH EDITION)

- Camaschella, C. (2015). Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*, 372(19), 1832–1843. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1401038>
- Czerny, M., Grabenwöger, M., Berger, T., Aboyans, V., Della Corte, A., Jassar, A. S., Kallenbach, K., Misfeld, M., Trimarchi, S., & EACTS/STS Scientific Document Group. (2024). EACTS/STS Guidelines for diagnosing and treating acute and chronic syndromes of the aortic organ. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 65(2), Article ezad426. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad426>
- Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., Bonaros, N., Brida, M., Burri, H., Caselli, S., Doenst, T., Durante-Mangoni, E., Erba, P. A., Frank, D., Gallardo, E., Galiè, N., Habib, G., Lancellotti, P., Lionetti, G., Mancone, M., Mistiaen, W., Nienaber, C. A., ... ESC Scientific Document Group. (2023). 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *European Heart Journal*, 44(39), 3948–4042. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193>
- Dentali, F., Douketis, J. D., Lim, W., & Crowther, M. (2006). Combined aspirin-oral anticoagulant therapy in patients with mechanical heart valves: A systematic review and meta-analysis. *Archives of Internal Medicine*, 166(7), 724–731. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.7.724>
- Fleischmann, D., Afifi, R. O., Casanegra, A. I., Eleftheriades, J. A., Gleason, T. G., Hanneman, K., Hope, M. D., Hughes, G. C., Matsumura, J. S., Rylski, B., Trimarchi, S., & American Heart Association Council on Cardiovascular Radiology and Intervention. (2022). Imaging and surveillance of chronic aortic dissection: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation: Cardiovascular Imaging*, 15(3), Article e000075. <https://doi.org/10.1161/HCG.0000000000000075>
- Goddard, A. F., James, M. W., McIntyre, A. S., & Scott, B. B. (2021). British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325210>
- Horan, T. C., Andrus, M., & Dudeck, M. A. (2008). CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. *American Journal of Infection Control*, 36(5), 309–332. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2008.03.002>
- Inker, L. A., Eneanya, N. D., Coresh, J., Tighiouart, H., Wang, D., Sang, Y., Crews, D. C., Doria, A., Estrella, M. M., Froissart, M., Grams, M. E., Greene, T., Grubb, A., Gudnason, V., Gutiérrez, O. M., Kalil, R., Karger, A. B., Mauer, M., Navis, G., ... Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. (2021). New creatinine- and cystatin C–based equations to estimate GFR without race. *New England Journal of Medicine*, 385(19), 1737–1749. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102953>
- Isselbacher, E. M., Preventza, O., Hamilton Black, J., 3rd, Augoustides, J. G., Beck, A. W., Bolen, M. A., Braverman, A. C., Bray, B. E., Browne, M. M., Collins, J. D., Coselli, J. S., Desai, N. D., Fischbein, M. P., Gornik, H. L., Hornick, M. A., Huang, C. C., Johnston, W. F., Kelly, R. F., Klingensmith, N. J., ... ACC/AHA Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. (2022). 2022 ACC/AHA Guideline for the diagnosis and management of aortic disease. *Circulation*, 146(24), e334–e482. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001106>
- Kaul, P. (2017). Sternal reconstruction after post-sternotomy mediastinitis. *Journal of Cardiothoracic Surgery*, 12(1), Article 94. <https://doi.org/10.1186/s13019-017-0656-7>
- KDIGO CKD Work Group. (2013). KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney International Supplements*, 3(1), 1–150. <https://doi.org/10.1038/kisup.2012.73>
- Lau, C., Gregg, A., Ram, E., Mack, C. A., Krieger, K., Rahouma, M., Gambardella, I., Soletti, G., Jr., Gaudino, M., & Girardi, L. N. (2025). Long-term survival and operative outcomes of the Bentall procedure for aortic root aneurysm, aortic dissection, and endocarditis. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2025.09.018>
- Mach, F., Baigent, C., Catapano, A. L., Koskinas, K. C., Casula, M., Badimon, L., Chapman, M. J., De Backer, G. G., Delgado, V., Ference, B. A., Graham, I. M., Taskinen, M. R., Tokgozoğlu, L., Vardas, P. E., & ESC Scientific Document Group. (2020). 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*, 41(1), 111–188. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455>
- Mancia, G., Kreutz, R., Brunström, M., Burnier, M., Grassi, G., Januszewicz, A., Muiesan, M. L., Tsouf, K., Agabiti-Rosei, E., Azizi, M., Benetos, A., Borghi, C., Erdine, S., Gerds, E., Kahan, T., Konradi, A., Coca, A., McManus, R., Parati, G., ... ESH Scientific Council. (2023). 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*, 41(12), 1874–2071. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480>
- McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., ... ESC Scientific Document Group. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- McEvoy, J. W., McCarthy, C. P., Bruno, R. M., Brouwers, S., Canavan, M., Cecconi, C., Christodorescu, R. M., D'Agostino, R. B., Sr., de Simone, G., Ferro, C. J., Gevaert, S., Jordan, J., Kahan, T., Mahfoud, F., McManus, R. J., Moran, A. E., Narkiewicz, K., Nilsson, P. M., Pyörälä, M., ... ESC Scientific Document Group. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European Heart Journal*, 45(38), 3897–3972. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>
- Melby, S. J., Zierer, A., Damiano, R. J., Jr., & Moon, M. R. (2013). Importance of blood pressure control after repair of acute type A aortic dissection: 25-year follow-up in 252 patients. *The Journal of Clinical Hypertension*, 15(1), 63–68. <https://doi.org/10.1111/jch.12024>
- Rosendaal, F. R., Cannegieter, S. C., van der Meer, F. J., & Briët, E. (1993). A method to determine the optimal intensity of oral anticoagulant therapy. *Thrombosis and Haemostasis*, 69(3), 236–239. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1651587>
- Snook, J., Bhala, N., Beales, I. L. P., Cannings, D., Kightley, C., Logan, R. P. H., Pritchard, D. M., Sidhu, R., Surgenor, S., Thomas, W., Verma, A. M., & Goddard, A. F. (2021). British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. *Gut*, 70(11), 2030–2051. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325210>
- Vahanian, A., Beyersdorf, F., Praz, F., Milojevic, M., Baldus, S., Bauersachs, J., Capodanno, D., Conradi, L., De Bonis, M., De Paulis, R., Delgado, V., Freemantle, N., Gilard, M., Haugaa, K. H., Jeppsson, A., Jüni, P., Pierard, L., Prendergast, B. D., Sádaba, J. R., ... ESC/EACTS Scientific Document Group. (2022). 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. *European Heart Journal*, 43(7), 561–632. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab395>
- Zhang, Q., Simoneau, G., Verstuyft, C., Drouet, L., Bal dit Sollier, C., Alvarez, J. C., Rizzo-Padoin, N., Bergmann, J. F., Becquemont, L., & Mouly, S. (2011). Amoxicillin/clavulanic acid–warfarin drug interaction: A randomized controlled trial. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 71(2), 232–236. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2010.03824.x>